

Hemorragia digestiva

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PRONAP 2012 Modulo 4

Epidemiología:

- Es infrecuente en pediatría
- Habitualmente no grave
- En algunos casos puede comprometer la vida del niño
- Hospital “Sor María Ludovica”: mayor incidencia de hemorragia digestiva baja en relación a las altas

Clasificación topográfica endoscópica:

- ALTA: desde orofaringe hasta ángulo de Treitz.
- MEDIA: desde Treitz hasta válvula ileocecal.
- BAJA: desde ciego a orificio anal

Formas de presentación:

- **Hematemesis:**
 - Sangre expulsada por la boca
 - generalmente con el vómito
 - la lesión está por arriba del ángulo de Treitz
 - De color variable, desde rojorutilante, que indicaría un sangrado proximal (esófago), hasta un color negro, a veces en “borra de café”, por transformación digestión de la hemoglobina en estomago o duodeno
- **Melena:**
 - Sangre expulsada por el recto
 - De color oscuro y aspecto alquitranado, untuosa y maloliente
 - Suele originarse en tramos altos del aparato digestivo
 - Puede estar acompañada de hematemesis
 - Su aspecto se debe a la exposición de la sangre al contenido intestinal por un período de tiempo prolongado (8 horas aproximadamente)
 - Sangrado del yeyuno proximal pero también puede provenir de segmentos más distales y aún del colon derecho (tránsito intestinal lento)
- **Hematoquecia o proctorragia:**
 - Depositiones con sangre roja, rutilante, mezcladas o no con sangre negra
 - lesión por debajo del ángulo de Treitz, excepcionalmente por sangrados altos abundantes que provocarían aceleración del tránsito intestinal.
 - Presencia de gotas o estrías de sangre cubriendo la materia fecal : lesión anorrectal
 - En un cuadro diarreico con moco: cuadro infeccioso o inflamatorio
- **Hemorragia oculta:**
 - Aquella que no puede observarse macroscópicamente
 - Se detecta a través de test de laboratorio (Guayaco) o análisis microscópicos del material fecal o métodos inmunológicos
 - Pueden provenir de cualquier parte del aparato digestivo, y suele expresarse como anemia ferropénica.
- **Hemorragia de origen oscuro:**
 - Hemorragia de origen desconocido que persiste o recurre, después de haber realizado endoscopia alta, baja y tránsito baritado de intestino delgado normal
 - Puede presentarse como hemorragia visible u oculta.

- **Causas de “falsa hemorragia digestiva”:**

- **Hematemesis:**

- Sangrado ORL (realizarse inteconsulta con ORL):

- Hemoptisis: no es frecuente en pediatría y usualmente está asociada con síntomas respiratorios
 - Epistaxis con sangre deglutida: puede presentarse como hematemesis o melena.
 - Lesiones en la orofaringe :
 - Aftas
 - Gingivitis
 - Traumatismo dental
 - Amigdalitis
 - Angiomas

- Colorantes comerciales

- Deglución sangre materna

- **Melena:**

- Fármacos con hierro
 - Frutos rojos
 - Espinaca
 - Bismuto o carbón
 - Ingesta de tierra

- **Hematoquezia**

- Menstruación
 - Colorantes comerciales
 - Ampicilina
 - Hematuria

Diagnóstico diferencial según la presentación clínica:

Hematemesis	Hematoquezia melena	Sangrado rectal con diarrea	Sangrado rectal con materia fecal normal	Sangre rutilante con materia fecal dura	Sangrado oculto
Deglución de sangre	Divertículo de Meckel	Colitis infecciosa	Pólipo juvenil	Fisura anal	Esofagitis
Déficit de vitamina K	Pólipo juvenil distal	Síndrome urémico hemolítico	Hiperplasia linfociliar	Proctitis	Gastritis
Esofagitis	Isquemia intestinal	Enterocolitis necrotizante	Colitis eosinofílica	Úlcera rectal solitaria	Gastroenteritis eosinofílica
Úlcera péptica	Vasculitis	Colitis eosinofílica	Malformaciones vasculares	Hemorroides internas	Malformaciones vasculares
Gastritis	Hemorragia gastro intestinal alta	Enfermedad inflamatoria intestinal			Enfermedad celíaca
Várices esofágicas	Vólvulo intestinal	Hiperplasia linfociliar			Enfermedad inflamatoria intestinal
Malformaciones vasculares	Invaginación	Colitis parasitarias			
Hemobilia	Enfermedad inflamatoria Intestinal				
	Malformaciones vasculares				

Causas de sangrado por edad de presentación, localización y gravedad

Grupo de edad	Anemizante	Alto	Anemizante	Bajo
		No anemizante		No anemizante
Recién nacido	MAV Úlceras gástricas Alt. coagulación	APLV Gastropatía erosiva (estrés, AINE, infección)	Coagulopatía MAV Duplicación intestinal	NEC Vólvulo intest. Lesión anorrectal
De 1 mes a 2 años	Úlceras gástricas MAV APLV Úlcera de Curling	RGE APLV Gastropatía erosiva (estrés, AINE, infección)	Divertículo de Meckel MAV Duplicación int. PTI APLV	Diarrea infecc. Lesión anorrect. APLV Vólvulo Invaginación int. Pólipos Fisura anal
De 3 a 5 años	Várices esofágicas MAV Úlceras gástricas Mallory-Weiss	Gastropatía erosiva (estrés, AINE, infección) Alt. coagulación	Divertículo de Meckel MAV	Pólipos Diarrea infecc. Hiperplasia linfoidea nodular EII
Mayores de 5 años	Várices esofágicas Úlceras gástricas Alt. coagulación	Gastropatía erosiva (estrés, AINE, infección por <i>H. pylori</i>)	Divertículo de Meckel MAV	Pólipos Fisura anal Hemorroides Diarrea infecc. Colitis pseudom. EII

MAV: malformación arteriovenosa; NEC: enterocolitis necrotizante.

Evaluación:

1. Evaluación hemodinámica inicial rápida:

- a. Mejor indicador de pérdida de sangre significativa:
 - Cambios ortostáticos (al cambiar al paciente de la posición supina a la de sentado) de la:
 - frecuencia cardíaca (incremento en 20 latidos/minuto)
 - tensión arterial (disminución de la presión sistólica de 10 mm Hg o más)
 - Palidez
 - Agitación
 - Sudoración
 - taquicardia
 - Hipotensión arterial (esta es una complicación severa pero tardía)
 - Grado de afectación:

2. Acceso venoso: debido a que el paciente puede agravarse rápidamente

3. Disponer de sangre para su eventual utilización

4. Antecedentes:

- Clínicos-quirúrgicos
- Familiares
- Personales
- Medicamentos, sustancias ingeridas

5. Laboratorio:

- Hemograma completo
 - Hematocrito: Puede ser normal dentro de las primeras 24 h (no descarta la severidad del sangrado)
 - Volumen corpuscular bajo: sugeriría una pérdida sanguínea crónica
 - Trombocitopenia:
 - Consumo secundario a hiperesplenismo por hipertensión portal
 - Déficit plaquetario inmunológico
 - En enfermedades inflamatorias activas

- TP, TTPK
 - alterada podría corresponder a:
 - hemofilia
 - CID
 - Déficit de vitamina K
 - Enfermedad hepática
- GOT, GPT, FAL, GGT:
 - Enfermedad hepatocelular o de la vía biliar
 - Puede sugiere ruptura de varices esofágicas, secundaria a hipertensión portal
- Urea, creatinina
- Estado A/B venoso
- Glucemia
- Reacción del Guayaco en materia fecal:
 - Es una reacción no específica para sangre
 - Muchas sustancias con actividad peroxidasa pueden dar falsos positivos, como carnes rojas, ciertas frutas y vegetales como coliflor, brócoli, y preparaciones de hierro orales.
- Detección de Hb mediante una técnica monoclonal: test más preciso
- RN: puede deberse a la deglución de sangre materna por lesión del pezón o al pasar por el canal de parto. El diagnóstico se hace mediante el test Apt-Downey, que diferencia hemoglobina fetal de la del adulto

CON EL PACIENTE ESTABILIZADO:

Evaluación diagnóstica: anamnesis

- Tos o epistaxis.
- Otros síntomas digestivos.
- Aspecto de la sangre emitida
- Ingestión de gastrolesivos o cuerpos extraños.
- Antecedentes de enfermedad digestiva o hepática aguda o crónica.
- Antecedentes de canalización umbilical.
- Ingestión de fármacos, alimentos, aditivos y colorantes alimentarios.
- Posible ingestión de sustancias tóxicas.

Evaluación etiológica

- Exploración de piel:
 - Ictérica
 - Petequias o púrpura
 - Hemangiomas
 - Pigmentaciones
- Exploración naso-faríngea
 - Sangrado de nariz
 - Sangrado de amígdalas.
- Examen abdominal:
 - Organomegalias
 - Circulación colateral
- Examen anal y perianal
 - Inspección
 - **Tacto rectal:** Realizar siempre, evalúa sangre no eliminada por ano en materia fecal, ocasionalmente en este procedimiento se puede tocar el pólipo causante del cuadro
- El examen de la materia fecal: puede orientar en el sitio de origen
- Si la evolución es más prolongada o tórpida y con deterioro clínico se debe pensar en enfermedad inflamatoria intestinal.
- Si la hemorragia es masiva las etiologías más habituales serían:
 - Várices esofágicas
 - úlcera gastroduodenal
 - sangrado por divertículo de Meckel, o por un angioma.

Estudios por imágenes

1. Rx simple de abdomen de pie, nos permite identificar:
 - Obstrucción intestinal
 - Neumoperitoneo
 - Megacolon tóxico
 - Presencia de un cuerpo extraño
2. Tránsito baritado superior
 - No está indicado en la HDA
 - Un estudio contrastado de intestino delgado ayuda a confirmar el diagnóstico de enfermedad de Crohn e identificar otras anormalidades como un tumor o estenosis
3. Ecografía y Doppler:
 - Ante una sospecha de hipertensión portal
 - Permite detectar invaginación, espesor de la pared intestinal en patología como enfermedad inflamatoria o vasculitis
 - Pocas veces se utiliza como el primer paso para el estudio de HD
4. Tomografía computada y resonancia magnética:
 - Lesiones tumorales
 - Malformaciones vasculares
5. Gammagrafía con Tc 99:
 - Divertículo de Meckel
 - Duplicaciones intestinales
 - Deben ser solicitados ante una hemorragia digestiva de causas oscuras.
6. Angiografía :
 - Para lesiones sangrantes o pérdidas recurrentes con un volumen mayor de 0,5 ml/minuto

Endoscopia:

- Método de elección para evaluar una HDA
- Se realiza con sedación
- Endoscopia alta: permite inspeccionar: estómago e intestino proximal
- Colonoscopia : para valorar un sangrado colónico e íleon (para confirmar una hiperplasia linfocitaria)
- Es terapéutico si se trata de un pólipo juvenil
- Permite obtener material para estudio histológico
- Si el procedimiento es realizado en las primeras 24 hs el porcentaje de identificación del sitio de sangrado es de 82-95%, mientras que si es realizado más allá de las 72 horas la posibilidad baja al 48%.

En pediatría, por lo general, remite espontáneamente, por lo cual la endoscopia de urgencia solo está indicada si los resultados fueran a cambiar la conducta clínica o si se requiriera realizar intervención terapéutica.

La perforación gástrica es la única contraindicación absoluta, y las contraindicaciones relativas son trastornos de la coagulación, inestabilidad hemodinámica, alteración de la conciencia y compromiso respiratorio.

- Cápsula endoscópica: para el diagnóstico de hemorragia digestiva de origen oscuro
 - Puede hacerse ambulatorio
 - Para pacientes de más de 2 años
 - Desventajas: no se puede realizar tratamiento

- Enteroscopia por pulsión de doble balón
 - Facilita el avance del endoscopio luego del ángulo de Treitz permitiendo el diagnóstico y tratamiento de lesiones yeyuno-ileales.
 - Solo puede realizarse en niños mayores

Tratamiento

“Una hemorragia digestiva, independientemente de su gravedad, debe ser evaluada por un gastroenterólogo para su adecuado manejo, aunque la gran mayoría son autolimitadas y sólo necesitan observación”

Paciente descompensado hemodinámicamente:

- Internación en UTIP.
- Acceso venoso seguro.
- Administración de O₂.
- Infusión de 15-20 ml de solución fisiológica, hasta disponer de sangre o glóbulos sedimentados.
- Sonda vesical y SNG permanente si hay compromiso del sensorio o en el neonato.
- Una vez estabilizado hemodinámicamente el paciente, se procederá a realizar la endoscopia alta

Paciente compensado

1. Acceso venoso

2. SNG + Aspirado gástrico:

- Diferencia si se trata de una hemorragia alta o baja
- Cuantifica gravedad de la misma
- Previene la dilatación gástrica
- Evacuación de sangre y coágulos
- La existencia de várices esofágicas no constituye una contraindicación
- El aspirar un contenido claro o biliar descartaría una hemorragia activa de esófago o estómago
- Mantenimiento de SNG abierta: permite controlar la presencia e intensidad del sangrado
- El lavado con suero salino frío carece de utilidad y está contraindicado por el riesgo de hipotermia sobre todo en niños pequeños. Si fuera necesario se realiza para fines diagnósticos (preparación previa a una endoscopia) utilizando suero salino a temperatura ambiente

1. Hemorragia alta no variceal

- La mayoría de las lesiones son mucosas
- El 70% remite espontáneamente y el 85%, si aplicamos tratamiento médico; solo un 15% requerirá tratamiento endoscópico.
- El laboratorio inicial es normal
- Tratamiento:
 - SNG: para monitorear la continuidad del sangrado y también como el primer paso para distinguir entre una pérdida alta o baja, sin embargo un líquido gástrico claro o bilioso no excluye un origen duodenal
 - Se inicia con omeprazol en doble dosis en bolo y luego por infusión continua por 72 h; después del día 4 al 7, cada 6-8 h por vía endovenosa, y se puede usar en doble dosis; y, a partir de la semana, dosis habitual de 0,3 a 3 mg/kg/día, dosis máxima de 80 mg/día.
 - Protectores de mucosa
 - Controles clínicos estrictos
 - Pautas de alarma a los padres
 - Si el sangrado es intenso debe efectuarse una endoscopia alta donde según el hallazgo será el tratamiento:
 - Esofagitis péptica y Gastritis: Inhibidores de secreción ácida y protectores de mucosa.
 - Úlcera péptica gástrica o duodenal: Si en el estudio no hay sangrado activo y se visualiza un coágulo sobre la lesión podría tomarse una conducta expectante e iniciar tratamiento médico con inhibidores de secreción ácida y protectores de mucosa. Si encontramos un vaso visible con sangrado activo o “babeando” se pueden realizar diversos tratamientos:
 - Inyección local de SF, SF + adrenalina, agentes esclerosantes

- Electrocoagulación con sonda bipolar o argón
- Pinza “caliente”
- Clips

2. Hemorragia alta variceal (HT portal):

- Después de haber estabilizado hemodinámicamente al paciente y con control de los signos vitales en UTI, se procede al tratamiento específico:
 - Farmacológico
 - Somatostatina
 - Octreótido
 - Terlipresina
 - Endoscópico:
 - Bandas
 - Escleroterapia
 - Mecánico:
 - Balón de Sengstaken-Blakemore
 - Quirúrgico:
 - Shunt portosistémico
 - Transección esofágica
 - TIPS
 - Trasplante hepático

Hemorragia digestiva baja:

- Habitualmente no causan trastornos hemodinámicos (excepto en el divertículo de Meckel o una hemorragia alta que se presente como enterorragia)
- 1º. Valorar el estado hemodinámico del paciente y tomar las medidas adecuadas
- 2º. Anos copia y tacto rectal
- Sangrado + defecación dolorosa:
 - Buscar presencia de patología orificial y realizar tratamiento local
- Lactante con *proctorragia indolora*:
 1. Descartar etiología infecciosa
 2. Pensar en intolerancia a la proteína de leche de vaca: administrará hidrolizado proteico, si el paciente se alimenta con LM únicamente se realiza dieta libre de lácteos a la madre
Una respuesta favorable se verá a los 10-15 días
- Paciente de más edad con proctorragia indolora:
 - Colonoscopia y si se halla un pólipo se efectuará una polipsectomía.
- *Proctorragia*+ trastornos hemodinámicas :
 - Cámara gamma para divertículo de Meckel, si es positivo: tratamiento quirúrgico
- Endoscopia:
 - Elementos (+) de una enfermedad inflamatoria: tratamiento médico correspondiente
 - Malformación vascular: Utilizar angiografía como método diagnóstico y posiblemente terapéutico.
- Sin hallazgo de etiología + medidas terapéuticas sin compensación hemodinámica (lo que es muy infrecuente) o si hay signos de obstrucción :
 - Transfusiones de sangre + *Exploración quirúrgica*

Algoritmo:

Hemorragia digestiva alta

- Anamnesis y exploración clínica
- Valoración y estabilización hemodinámica
- Colocar vía
- Colocar sonda nasogástrica para comprobar sangrado y características
- Analítica:
 - Hematocrito
 - Hb
 - Uremia, creatinina
 - TP, TTPK
- Tacto rectal
- Sangre oculta

Evaluación por Gastroenterología + Endoscopia

Sin diagnóstico

Estable

Observar

Inestable

Arteriografía con GR marcados

Transito > 85ml/Kg

Cirugía

Con diagnóstico

Variceal

Tratamiento endoscópico

Balón

Cirugía

No Variceal

Tratamiento médico

Tratamiento endoscópico

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

Anamnesis. Examen clínico

Valorar pérdidas. Descartar hemorragia digestiva alta

VOLUMEN BAJO

Coprocultivo

Diarrea infecciosa

Valorar obstrucción

Ecografía Colonoscopia

VOLUMEN ELEVADO

Valoración clínica

Gammacámara VEDA. Angiografía

Cirugía

TRATAMIENTO ESPECÍFICO